

Пальцьове дослідження прямої кишки

Сценарій. Ви лікар-хірург. Ви оглядаєте на санітарному пропускнику лікарні пацієнта 35 років, якого доставила бригада швидкої медичної допомоги. Скарги на загальну слабкість, головне кружіння, блювоту типу «кавової гущі». Ви проводите пальцеве дослідження прямої кишки. Визначте консистенцію та колір вмісту прямої кишки.

№	Маніпуляція	Форма представлення
1	Встановити контакт з пацієнтом (привітатись, представитись, позначити свою роль). Коректне розташування лікар-пацієнт (лежачи на боці з зігнутими в тазостегнових та колінних суглобах ногами, у колінно-ліктьовому положенні)	
2	Отримати інформаційну згоду на проведення діагностичних маніпуляцій	Сказати
3	Обробити руки антисептиком на гігієнічному рівні (лікар в рукавичках), вказівний палець рясно змастити змазкою	Виконати
4	Оглянути області заднього проходу	Виконати/ Сказати
5	Коректне пальцьове дослідження прямої кишки (обережно ввести вказівний палець в задній прохід, послідовно обмацати стінки анального каналу, послідовно обстежити стінку кишки по всій поверхні та на всьому доступному протязі, провести палець у ампулу прямої кишки)	Виконати
6	Оцінити: - стан просвіту ампули прямої кишки (зіяння, звуження)	Сказати
7	Оцінити: - характер відокремлюваного (слизове, кров'янисте, гнійне) - колір калових мас	Сказати
8	Визначити відхилення від норми (так, ні)	Сказати
9	Уточнити у пацієнта його самопочуття	Сказати

Діагностика

3.1. Оцінка тону анального сфінктера

Сказати: «Під час введення пальця у пряму кишку тонус анального сфінктера збережений, симетричний. Ознак парезу або гіпертонусу не виявлено. Це свідчить про відсутність неврологічних порушень в цій ділянці.»

3.2. Оцінка наявності патологічних утворень, характеру випорожнень

Сказати: «У прямій кишці патологічних утворень не пальпую — пухлиноподібних мас,

інфільтратів, поліпів немає. Амбула кишки порожня. Кал на рукавичці відсутній, що

відповідає анамнезу пацієнта — випорожнень не було добу. Ознак крові чи патологічних домішок не виявлено.»

4. Визначення тактики ведення та лікування

4.1. Необхідність додаткових методів дослідження (ректороманоскопія, колоноскопія)

Сказати: «Пацієнту показано проведення ректороманоскопії або колоноскопії для уточнення стану слизової прямої та сигмоподібної кишки, виключення новоутворень або механічної обструкції, що могла б бути причиною запору, особливо в умовах жовтяниці.»

4.2. Призначення медикаментозної терапії

«З огляду на діагноз механічної жовтяниці (ймовірно – обтурація жовчної протоки каменем), призначаю:

1. Базова терапія:

Інфузійна терапія:

– 0,9% NaCl – 500 мл

– Розчин Рінгера – 400 мл

– Глюкоза 5% – 400 мл (можна з вітаміном С)

Гепатопротектор:

– Гептрал 400 мг в/в, 1 раз/добу

Спазмолітик:

– Дротаверин 2 мл 2% в/м 2 рази/добу

– Папаверин 2 мл 2% – альтернатива

Антибіотикопрофілактика (при лихоманці):

– Цефтріаксон 1 г в/в 2 рази/добу

– або Ципрофлоксацин 200 мг в/в 2 рази/добу

Ентеросорбенти:

– Ентеросгель або Смекта – перорально 3 рази/день